

4. Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed

4.1. Proceso de Negocio a Analizar

El proceso seleccionado para análisis corresponde al **Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed**. Este proceso tiene como propósito obtener, consolidar y analizar información proveniente del sistema RISPACS, con el fin de apoyar el seguimiento de la producción clínica, las ventas, los ingresos y otros indicadores relevantes para la gestión de la organización.

RISPACS constituye la principal fuente de información del proceso, ya que concentra datos asociados a pacientes, prestaciones realizadas, exámenes, sucursales, prestadores, financiadores, instituciones, valores y registros operacionales vinculados a la atención clínica. A partir de esta información, la responsable del proceso descarga reportes, los trabaja en Excel y genera análisis que permiten revisar el comportamiento de la operación según distintos criterios de gestión.

Actualmente, el proceso es ejecutado principalmente por Liz Bravo, Jefe de Administración, quien accede a RISPACS, consulta la información disponible, delimita el período de análisis principalmente mediante el filtro de fecha, descarga los reportes correspondientes y posteriormente trabaja los datos en Excel, aplicando los filtros y criterios de clasificación necesarios. Estos archivos permiten analizar información relacionada con cantidad de prestaciones, producción, ventas, ingresos, convenios, Fonasa, Isapres, prestadores y sucursales.

A nivel general, el proceso puede descomponerse en las siguientes etapas:

1. Identificación de la necesidad de preparar información de gestión clínica.
2. Ingreso al sistema RISPACS y consulta de información operacional.
3. Delimitación del período de análisis en RISPACS mediante el filtro de fecha.
4. Descarga o exportación de reportes desde RISPACS.
5. Trabajo, filtrado y clasificación de la información en Excel según sucursal, tipo de examen, prestador, financiador, institución, sociedad y valor.
6. Generación de reportes o análisis de producción, ventas e ingresos.
7. Entrega o presentación de la información a jefatura para su revisión y uso en la toma de decisiones.

Si bien el proceso presenta una menor complejidad estructural que otros procesos levantados en MauleMed, su importancia radica en que permite transformar datos operacionales registrados en RISPACS en información útil para el control de gestión. En este sentido, constituye un proceso relevante para apoyar decisiones comerciales, presupuestarias y operacionales dentro de la organización.

4.2. Motivación y Beneficios Esperados

4.2.1. Motivación

El proceso de Control e Informes de Gestión Clínica constituye una actividad relevante para MauleMed, ya que permite disponer de información consolidada sobre el desempeño de la operación clínica y comercial. A través de este proceso, la organización puede analizar la producción realizada, los ingresos asociados a las prestaciones, la participación de distintos financiadores y el comportamiento de las ventas por sucursal, tipo de examen o prestador.

Actualmente, la información requerida se obtiene principalmente desde RISPACS y posteriormente se trabaja en Excel. Esta forma de operación permite generar los análisis necesarios, pero presenta un componente manual importante, debido a que la responsable del proceso debe descargar información, aplicar filtros, clasificar datos y consolidar reportes de acuerdo con los criterios requeridos por la jefatura.

La motivación principal para levantar este proceso es documentar formalmente su funcionamiento actual, identificar las actividades que lo componen, comprender los criterios utilizados para trabajar la información y reconocer eventuales brechas asociadas a manualidad, dependencia de conocimiento individual, oportunidad de la información y trazabilidad de los reportes generados.

Asimismo, el levantamiento resulta relevante debido a que la información generada mediante este proceso es utilizada para apoyar decisiones de gestión. Contar con datos confiables sobre producción, ventas, ingresos, convenios y financiadores permite evaluar el desempeño de la organización y detectar oportunamente desviaciones respecto de los resultados esperados.

4.2.2. Beneficios Esperados

La realización del presente estudio permitirá obtener una comprensión clara del funcionamiento actual del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica, identificando sus principales actividades, actores, herramientas, entradas, salidas y mecanismos de control.

Entre los beneficios esperados se encuentran:

- Documentar formalmente un proceso que actualmente depende en gran medida del conocimiento operativo de su ejecutora principal.
- Identificar las fuentes de información utilizadas para la elaboración de reportes de gestión clínica.
- Comprender los criterios de filtro y clasificación aplicados sobre la información descargada desde RISPACS.
- Reconocer oportunidades de mejora asociadas a la consolidación, trazabilidad y disponibilidad de la información.
- Facilitar la identificación de indicadores relevantes para el seguimiento de producción, ventas e ingresos.
- Generar una base documental que permita, en etapas posteriores, evaluar alternativas de automatización o generación de reportes más oportunos.
- Apoyar la toma de decisiones mediante información más estructurada, ordenada y comprensible para la organización.

4.3. Estado Actual del Proceso de Negocio

4.3.1. Descripción Narrativa del Proceso

El proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed tiene como finalidad preparar información de gestión a partir de los datos registrados en RISPACS. Esta información permite analizar la producción clínica, las ventas, los ingresos y distintos criterios relevantes para la administración de la organización, tales como sucursal, tipo de examen, prestador, financiador, institución y valor de la prestación.

El proceso comienza cuando surge la necesidad de preparar información de gestión clínica para revisión interna. Esta necesidad puede estar asociada al seguimiento de ventas, evaluación de producción, revisión de ingresos o análisis del comportamiento de las prestaciones realizadas durante un determinado período.

Una vez identificada la necesidad, Liz Bravo, Jefe de Administración, ingresa al sistema RISPACS con sus credenciales. Desde el sistema accede al módulo de informes de producción, donde se encuentra disponible la información asociada a las prestaciones realizadas, pacientes, sucursales, prestadores, financiadores, instituciones y valores registrados.

Posteriormente, Liz define el período de consulta dentro de RISPACS. En esta etapa, el filtro aplicado directamente en el sistema corresponde principalmente a la **fecha** o rango de fechas que

se desea analizar. Una vez delimitado el período, la información es descargada o exportada desde RISPACS en formato Excel.

Luego de descargar el archivo, Liz trabaja la información directamente en Excel. En esta etapa se aplican los filtros y criterios de análisis requeridos para ordenar y clasificar los datos. A diferencia de la consulta inicial en RISPACS, el análisis detallado se realiza sobre el archivo descargado, filtrando por variables como sucursal, tipo de examen, prestación, prestador, financiador, institución, sociedad, valor y otros campos relevantes para la gestión.

A partir de este trabajo en Excel, Liz clasifica y ordena la información según los criterios requeridos por la jefatura. En esta etapa se analiza, por ejemplo, la cantidad de prestaciones realizadas, los ingresos asociados, la participación de Fonasa, Isapres y convenios, y la distribución de producción por sucursal o prestador.

Una vez trabajada la información, se consolida en un archivo Excel de gestión. Este archivo constituye la principal herramienta de apoyo para preparar los reportes o análisis requeridos. Dependiendo de la necesidad específica, la información puede presentarse como una tabla resumen, un reporte interno o una base de análisis utilizada para revisar producción, ventas e ingresos.

Finalmente, la información preparada es entregada o presentada a la jefatura, quien la utiliza para revisar el desempeño del período, evaluar la evolución de las ventas, analizar ingresos y considerar posibles acciones comerciales, presupuestarias u operacionales. El proceso finaliza cuando la información queda disponible para su revisión y uso en la toma de decisiones.

Actualmente, el proceso presenta una estructura simple y pocos participantes directos. Sin embargo, mantiene una alta dependencia de actividades manuales en Excel y del conocimiento de la responsable del proceso, especialmente en lo relativo a la clasificación de datos, aplicación de filtros sobre el archivo descargado e interpretación de la información proveniente de RISPACS.

4.3.2. Elementos Principales que Describen el Proceso

Con el fin de comprender de mejor manera el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed, resulta necesario identificar los principales elementos que participan en su ejecución. Estos elementos corresponden a las entidades de información utilizadas durante el proceso, las etapas que lo componen, los ejecutores responsables de su realización, los clientes que reciben sus resultados y los proveedores que suministran las entradas necesarias para su funcionamiento.

Entidades. Las entidades corresponden a los objetos de información que ingresan, se generan o son utilizados durante la ejecución del proceso. En este caso, las entidades principales se relacionan con la información extraída desde RISPACS y con los archivos Excel utilizados para su análisis posterior.

- **Información registrada en RISPACS:** entidad de entrada correspondiente a los datos disponibles en el sistema, asociados a pacientes, prestaciones realizadas, producción clínica, valores, financiadores, instituciones, sucursales y prestadores.
- **Filtro de fecha:** entidad de entrada utilizada para delimitar el período de análisis dentro de RISPACS antes de realizar la descarga de información.
- **Reporte descargado desde RISPACS:** entidad interna generada a partir de la exportación de información del sistema, generalmente en formato Excel.
- **Archivo Excel de trabajo:** entidad interna utilizada por Liz Bravo para filtrar, ordenar, clasificar y analizar la información descargada desde RISPACS.
- **Criterios de clasificación:** entidad interna compuesta por las variables utilizadas para segmentar la información, tales como sucursal, tipo de examen, prestación, prestador, financiador,

institución, sociedad y valor.

- **Reporte de gestión clínica:** entidad de salida correspondiente a la información preparada para revisión de jefatura, incluyendo análisis de producción, ventas, ingresos, convenios, Fonasa, Isapres y otros criterios relevantes.
- **Información para toma de decisiones:** entidad de salida utilizada por la jefatura para evaluar el desempeño de la operación y analizar posibles acciones comerciales, presupuestarias u operacionales.

Etapas. A nivel macro, el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica puede dividirse en seis etapas principales:

1. **Identificar necesidad de información:** corresponde al momento en que surge la necesidad de preparar información de gestión clínica para revisión interna o para análisis por parte de la jefatura.
2. **Consultar información en RISPACS:** consiste en ingresar al sistema y acceder al módulo de informes de producción, delimitando el período de consulta mediante el filtro de fecha.
3. **Descargar información desde RISPACS:** corresponde a la exportación de la información disponible en el sistema hacia un archivo Excel.
4. **Trabajar información en Excel:** contempla la aplicación de filtros, clasificación y ordenamiento de los datos descargados, considerando variables como sucursal, tipo de examen, prestador, financiador, institución, sociedad y valor.
5. **Preparar reportes de gestión:** consiste en consolidar la información relevante para generar reportes o análisis asociados a producción, ventas, ingresos y comportamiento de los financiadores.
6. **Entregar información a jefatura:** corresponde a la disponibilización o presentación de la información preparada para que sea revisada y utilizada en la toma de decisiones.

Ejecutores. Los principales ejecutores que participan en el proceso son los siguientes:

- **Liz Bravo, Jefe de Administración:** responsable principal de ejecutar el proceso. Ingresa a RISPACS, descarga la información, trabaja los datos en Excel, aplica filtros y criterios de clasificación, prepara los reportes de gestión y entrega la información a jefatura.
- **Jefatura:** recibe la información preparada, revisa los resultados de producción, ventas e ingresos, y utiliza los reportes como apoyo para la toma de decisiones comerciales, presupuestarias u operacionales.

Clientes. Los clientes del proceso corresponden a los actores internos que utilizan la información generada para realizar análisis o tomar decisiones.

- **Jefatura de MauleMed:** principal cliente interno del proceso, ya que utiliza la información para revisar producción, ventas, ingresos y posibles acciones de gestión.
- **Administración:** utiliza la información como apoyo para el seguimiento de resultados y la preparación de análisis internos.
- **Dirección o gerencia:** cliente indirecto del proceso, en la medida en que la información consolidada puede apoyar decisiones de mayor nivel relacionadas con desempeño, presupuesto, ventas o planificación.

Proveedores. Los proveedores corresponden a las entidades, sistemas o actores que suministran la información necesaria para ejecutar el proceso.

- **RISPACS:** principal proveedor de información del proceso, ya que contiene los datos asociados a pacientes, prestaciones, producción, valores, prestadores, financiadores, instituciones y sucursales.
- **Áreas operacionales y administrativas:** proveedores indirectos de información, en tanto registran o generan datos en RISPACS durante la operación diaria de la organización.
- **Personal de admisión y atención clínica:** proveedores indirectos, debido a que los registros asociados a llegada, ingreso, atención y prestación del paciente alimentan la información disponible en el sistema.

4.3.3. Aplicación de Herramienta SIPOC

La herramienta SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) permite representar de manera resumida los elementos principales que intervienen en un proceso de negocio. Su utilización facilita la identificación de los proveedores, entradas, actividades principales, salidas y clientes involucrados, proporcionando una visión global del funcionamiento del proceso.

Para el caso del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed, la aplicación de esta herramienta permite comprender cómo la información registrada en RISPACS es transformada en reportes y análisis de gestión utilizados por la jefatura para apoyar la toma de decisiones.

La Tabla 1 presenta el análisis SIPOC correspondiente al proceso estudiado.

Tabla 1: Análisis SIPOC del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
RISPACS	Información de producción clínica	1. Identificar necesidad de información	Reporte descargado desde RISPACS	Liz Bravo
Áreas operacionales y administrativas	Datos de pacientes, prestaciones, prestadores y sucursales	2. Consultar información en RISPACS	Excel de trabajo	Administración
Personal de admisión y atención clínica	Datos de financiadores, instituciones, valores y fechas	3. Descargar información desde RISPACS	Información clasificada por criterios de gestión	Jefatura
Liz Bravo	Criterios de análisis y clasificación	4. Filtrar y clasificar información en Excel	Reportes de producción, ventas e ingresos	Dirección o gerencia
Jefatura	Necesidad de análisis de gestión	5. Preparar reportes de gestión clínica	Información disponible para análisis y toma de decisiones	Usuarios internos de gestión

Como se observa en la Tabla 1, el proceso se inicia a partir de la necesidad de contar con información de gestión clínica y utiliza como fuente principal los datos registrados en RISPACS. Estos datos son descargados, trabajados y clasificados en Excel por Liz Bravo, permitiendo generar reportes y análisis que apoyan la revisión de producción, ventas, ingresos y comportamiento de los financiadores.

El análisis SIPOC evidencia que, aunque el proceso posee una estructura simple, cumple una función relevante dentro de la gestión interna de MauleMed, ya que conecta la información operacional

registrada en el sistema con las necesidades de análisis de la jefatura.

4.3.4. Procesos Relacionados

El proceso de Control e Informes de Gestión Clínica mantiene relación con otros procesos internos de MauleMed, ya que utiliza información generada durante la operación diaria de la organización y entrega resultados que pueden apoyar decisiones comerciales, administrativas y financieras.

En primer lugar, se relaciona con el proceso de **Atención Clínica**. La información utilizada para la elaboración de los reportes proviene de los registros generados durante la atención de pacientes, tales como prestaciones realizadas, tipo de examen, prestadores, sucursales, hora de llegada, hora de ingreso y otros antecedentes registrados en RISPACS. Por lo tanto, la calidad y completitud de los datos ingresados durante la atención impacta directamente en la utilidad de los informes generados.

En segundo lugar, el proceso se vincula con la **Gestión Comercial y de Ventas**, dado que los reportes permiten analizar ingresos, cantidad de prestaciones, distribución por financiador, participación de convenios, Fonasa e Isapres, y comportamiento de la producción por sucursal o prestador. Esta información puede ser utilizada por la jefatura para evaluar el desempeño comercial y definir acciones orientadas a mejorar los resultados de la organización.

Asimismo, existe una relación con el proceso de **Gestión Financiera**, debido a que parte de la información obtenida desde RISPACS también puede ser utilizada para analizar ingresos y apoyar revisiones asociadas a ventas y caja. Sin embargo, actividades como la revisión de cartolas bancarias, descarga de libros desde el Servicio de Impuestos Internos o análisis contable mediante Defontana corresponden a procesos distintos y no forman parte del flujo principal del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica.

Finalmente, el proceso se relaciona con la **Gestión Operacional**, en la medida en que la información registrada en RISPACS también permite revisar variables asociadas a la operación clínica, tales como cantidad de exámenes, comportamiento por tipo de prestación, tiempos de atención e indicadores de asistencia de pacientes. Estos elementos permiten complementar el análisis de gestión y entregar una visión más amplia del desempeño operativo de MauleMed.

La Figura 1 presenta las principales relaciones identificadas entre el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica y otros procesos relevantes de MauleMed.

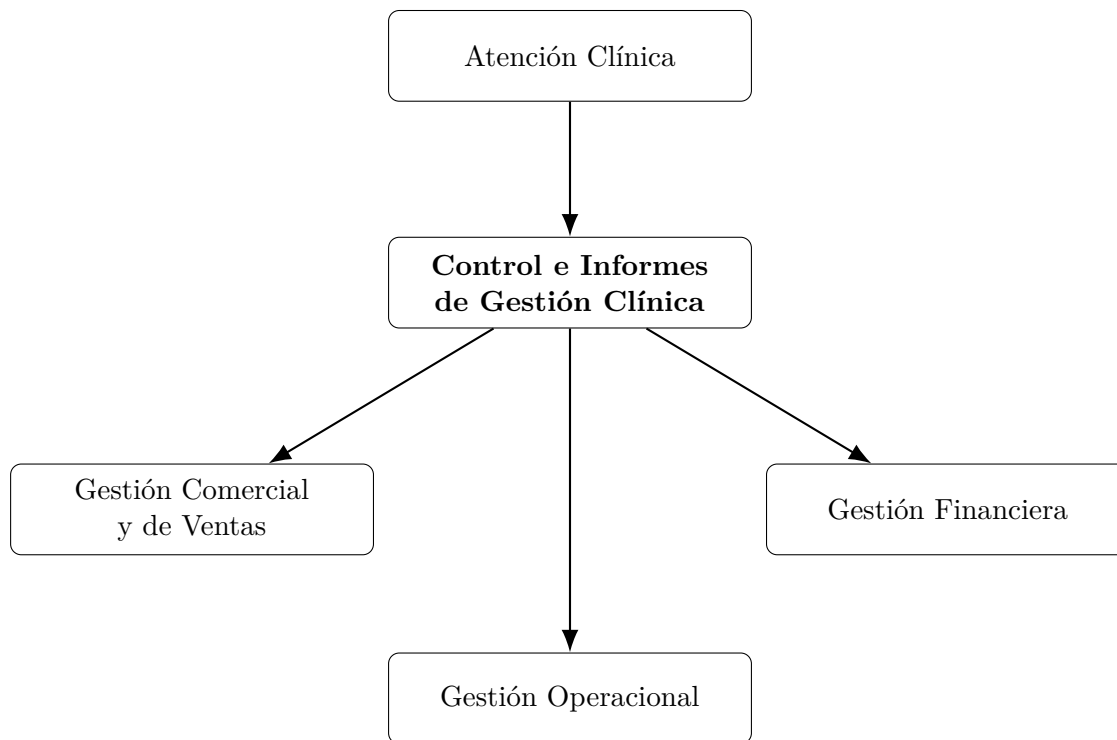


Figura 1: Procesos relacionados con el Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed

Como se observa en la Figura 1, el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica actúa como un proceso articulador entre los registros operacionales generados durante la atención clínica y las necesidades de análisis de las áreas administrativas, comerciales y financieras. Su valor principal se encuentra en transformar información registrada en RISPACS en reportes útiles para la gestión interna.

4.3.5. Herramientas de Apoyo

Para la ejecución del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica se utilizan principalmente dos herramientas: RISPACS y Microsoft Excel.

- **RISPACS:** corresponde al sistema fuente del proceso. Desde este sistema se obtiene la información asociada a producción clínica, prestaciones realizadas, pacientes, sucursales, prestadores, financiadores, instituciones, valores y fechas. En RISPACS se delimita principalmente el período de consulta mediante el filtro de fecha y posteriormente se descarga la información requerida.
- **Microsoft Excel:** corresponde a la herramienta utilizada para trabajar la información descargada desde RISPACS. En Excel se aplican los filtros y criterios de clasificación necesarios para analizar la información por sucursal, tipo de examen, prestación, prestador, financiador, institución, sociedad y valor. Además, permite preparar los reportes o análisis que posteriormente son revisados por la jefatura.

Actualmente, el proceso no cuenta con una herramienta automatizada de reportería o visualización, por lo que la preparación de la información depende principalmente del trabajo manual realizado en Excel.

4.3.6. Aplicación de Herramienta RECI

La herramienta RECI (Responsable, Ejecutor, Consultado e Informado) permite identificar los roles que participan en cada etapa del proceso y el nivel de involucramiento que poseen en su ejecución. Su aplicación facilita la comprensión de las responsabilidades actuales, especialmente en procesos donde las actividades se concentran en pocos actores.

Para el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed se identificaron los siguientes roles principales:

- **Liz Bravo, Jefe de Administración:** responsable principal de ejecutar el proceso, desde la consulta y descarga de información en RISPACS hasta el trabajo de los datos en Excel y la preparación de los reportes de gestión.
- **Jefatura:** cliente interno del proceso, encargado de revisar la información generada y utilizarla como apoyo para el análisis de producción, ventas, ingresos y posibles decisiones de gestión.

Tabla 2: Matriz RECI del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica

Etapas	Liz Bravo	Jefatura
1. Identificar necesidad de información de gestión clínica	E/R	C
2. Consultar información en RISPACS	E/R	I
3. Descargar información desde RISPACS	E/R	I
4. Trabajar, filtrar y clasificar información en Excel	E/R	I
5. Preparar reportes de producción, ventas e ingresos	E/R	I
6. Entregar información para revisión	E/R	I
7. Revisar información generada	I	E/R
8. Evaluar acciones comerciales, presupuestarias u operacionales	I	E/R

RECI a nivel de etapas. La matriz RECI evidencia que el proceso se encuentra altamente concentrado en Liz Bravo, quien cumple simultáneamente los roles de ejecutora y responsable en la mayor parte de las etapas operativas. La jefatura participa principalmente como cliente interno del proceso, recibiendo la información preparada y utilizándola como apoyo para el análisis y la toma de decisiones.

Esta distribución de roles es coherente con la baja complejidad estructural del proceso; sin embargo, también evidencia una dependencia relevante del conocimiento operativo de la responsable principal, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de la información en Excel y la aplicación de criterios de clasificación.

4.3.7. Modelado BPMN del Proceso

Con el objetivo de representar el funcionamiento actual del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed, se desarrolló un modelo BPMN a partir de la información recopilada

durante las reuniones de levantamiento realizadas con Liz Bravo, Jefe de Administración, y de la posterior validación del flujo del proceso.

A diferencia de otros procesos levantados en MauleMed, este proceso presenta una estructura más simple y lineal, debido a que involucra pocos participantes directos y se desarrolla principalmente mediante el uso de RISPACS y Microsoft Excel. Por esta razón, se elaboró un único modelo BPMN AS IS, orientado a representar el funcionamiento actual del proceso sin incorporar aún propuestas de automatización o rediseño futuro.

El proceso comienza cuando surge la necesidad de preparar información de gestión clínica. A partir de esto, Liz Bravo ingresa a RISPACS, accede al módulo correspondiente, define el período de consulta mediante el filtro de fecha y descarga la información requerida. Posteriormente, la información es trabajada en Excel, donde se aplican los filtros y criterios de clasificación necesarios para analizar los datos por sucursal, tipo de examen, prestación, prestador, financiador, institución, sociedad y valor.

Una vez clasificada la información, se preparan los reportes o análisis de gestión clínica, los cuales permiten revisar producción, ventas, ingresos, cantidad de prestaciones y comportamiento de financiadores como Fonasa, Isapres y convenios. Finalmente, la información es entregada o presentada a la jefatura, quien la utiliza como apoyo para la revisión de resultados y la evaluación de posibles acciones comerciales, presupuestarias u operacionales.

La Figura 2 presenta el modelo BPMN del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed.

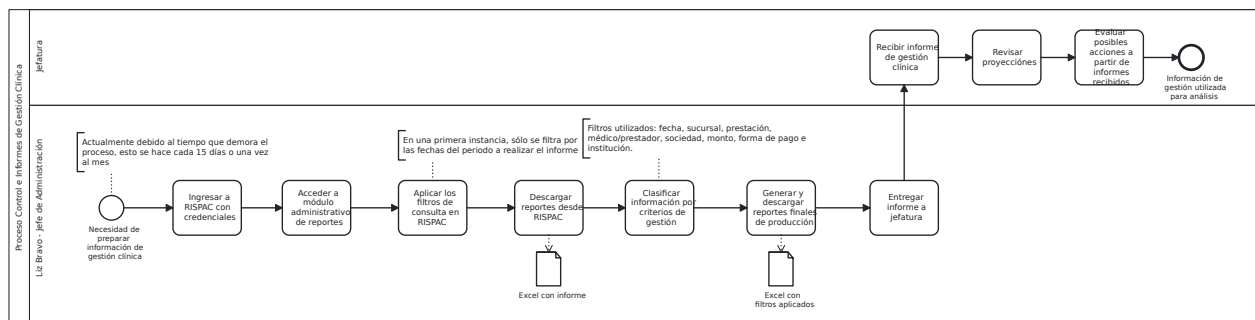


Figura 2: Modelo BPMN del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica de MauleMed

Como se observa en la Figura 2, el proceso se concentra principalmente en las actividades ejecutadas por Liz Bravo, quien es responsable de consultar, descargar, filtrar, clasificar y preparar la información proveniente de RISPACS. La jefatura participa al final del proceso como cliente interno, recibiendo la información generada y utilizándola para apoyar el análisis de gestión.

El modelo BPMN permite evidenciar que el proceso cumple actualmente su propósito de generar información útil para la toma de decisiones. Sin embargo, también muestra que el flujo depende de actividades manuales realizadas en Excel, especialmente en la aplicación de filtros, clasificación de datos y preparación de reportes. Esta característica constituye uno de los principales elementos a considerar en el diagnóstico del proceso y en la posterior identificación de oportunidades de mejora.

4.4. Aplicación del Modelo de Madurez de Hammer

Con el propósito de complementar el levantamiento del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica y evaluar el grado de desarrollo de las capacidades organizacionales que lo sustentan, se aplicó el Modelo de Madurez de Procesos propuesto por Michael Hammer.

Este modelo permite analizar un proceso no solo desde sus resultados, sino también desde las capacidades que permiten ejecutarlo de manera consistente. Para ello, considera cinco facilitadores principales: Diseño, Ejecutores, Responsable, Infraestructura y Métricas.

La evaluación presentada se desarrolló utilizando como fuente de evidencia las reuniones de levantamiento realizadas con Liz Bravo, la validación del modelo BPMN y el análisis del funcionamiento actual del proceso. Dado que se trata de un proceso de menor complejidad estructural, la aplicación del modelo se enfoca en identificar brechas concretas asociadas a documentación, dependencia de ejecución manual, soporte tecnológico y uso de indicadores.

4.5. Modelo de Madurez de Hammer

El Modelo de Madurez de Hammer evalúa cinco facilitadores que, en conjunto, determinan la capacidad de una organización para ejecutar un proceso de forma consistente, controlada y sostenible. Cada facilitador se compone de distintas capacidades específicas, denominadas *capabilities*, que permiten evaluar aspectos particulares del proceso.

Tabla 3: Facilitadores del Modelo de Madurez de Hammer

Facilitador	Descripción
Diseño	Evalúa la forma en que el proceso ha sido definido, considerando su propósito, contexto organizacional y grado de documentación.
Ejecutores	Evalúa si las personas que participan en el proceso poseen el conocimiento, habilidades y comportamientos necesarios para ejecutarlo adecuadamente.
Responsable	Analiza la existencia de un responsable del proceso con claridad sobre su rol, autoridad y participación en la gestión del desempeño.
Infraestructura	Evalúa el soporte organizacional y tecnológico disponible para ejecutar el proceso, incluyendo sistemas de información y herramientas de trabajo.
Métricas	Evalúa la existencia y utilización de indicadores que permitan monitorear el desempeño del proceso y apoyar la toma de decisiones.

Tabla 4: Capabilities evaluadas en el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	Descripción
Diseño	Propósito	Evalúa si el objetivo del proceso se encuentra claramente definido y alineado con las necesidades de la organización.
	Contexto	Evalúa si el proceso se encuentra correctamente integrado con clientes, proveedores y otros procesos relacionados.
	Documentación	Evalúa el grado en que el proceso, sus actividades y criterios se encuentran formalmente documentados.
Ejecutores	Conocimiento	Evalúa el nivel de comprensión que poseen los participantes respecto del proceso.
	Habilidades	Evalúa las competencias necesarias para ejecutar correctamente las actividades del proceso.
	Comportamiento	Evalúa si las conductas de los participantes favorecen el cumplimiento de los objetivos del proceso.
Responsable	Identidad	Evalúa la existencia de un responsable claramente identificado para el proceso.
	Actividades	Evalúa el grado en que el responsable gestiona activamente el desempeño y la mejora del proceso.
Infraestructura	Sistema de información	Evalúa el soporte tecnológico disponible para ejecutar el proceso.
	Recursos Humanos	Evalúa los mecanismos organizacionales que apoyan el desempeño de los ejecutores y la continuidad operacional.
Métricas	Definición	Evalúa si existen indicadores adecuados para medir el desempeño del proceso.
	Uso	Evalúa si dichos indicadores son utilizados para gestionar y mejorar el proceso.

4.6. Escala de Madurez

Para la evaluación se utiliza la escala P0–P4 del Modelo de Hammer. Esta escala permite representar el grado de desarrollo de cada capability, desde un nivel incipiente o inexistente hasta un nivel plenamente institucionalizado y orientado a la mejora continua.

Considerando la evidencia recopilada durante el levantamiento, las capacidades evaluadas se concentran principalmente entre los niveles P0 y P2, debido a que el proceso presenta un funcionamiento práctico y conocido por su responsable, pero con baja formalización, alta dependencia de Excel y ausencia de métricas formales de desempeño.

La Tabla 5 presenta la interpretación utilizada para caracterizar cada nivel durante el presente

estudio.

Tabla 5: Escala de madurez utilizada en la evaluación

Color	Nivel	Interpretación utilizada en este estudio
	P0	La capability no presenta evidencia suficiente de implementación o su desarrollo es incipiente.
	P1	La capability se encuentra parcialmente desarrollada; existen prácticas implementadas, aunque dependen significativamente de conocimiento tácito o mecanismos informales.
	P2	La capability se encuentra implementada y es aplicada de forma consistente durante la ejecución del proceso, aunque aún no evidencia características propias de integración organizacional.
	P3	La capability se encuentra integrada transversalmente dentro de la organización y es gestionada de manera sistemática.
	P4	La capability forma parte de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a la optimización permanente del proceso.

4.7. Evaluación de Madurez

La Tabla 6 presenta el resultado de la evaluación de las capacidades del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica utilizando el Modelo de Madurez de Hammer. Para cada *capability* se identifica el nivel de madurez alcanzado de acuerdo con la evidencia recopilada durante el levantamiento del proceso, la validación del BPMN y el análisis de las herramientas utilizadas actualmente.

Tabla 6: Evaluación de madurez del proceso según el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	P0	P1	P2	P3	P4
Diseño	Propósito			✓		
	Contexto			✓		
	Documentación		✓			
Ejecutores	Conocimiento		✓			
	Habilidades		✓			
	Comportamiento		✓			
Responsable	Identidad			✓		
	Actividades		✓			
Infraestructura	Sistema de información		✓			
	Recursos Humanos		✓			
Métricas	Definición	✓				
	Uso	✓				

4.8. Justificación de la Evaluación

Con el objetivo de respaldar la evaluación presentada en la Tabla 6, a continuación se expone la evidencia recopilada durante el levantamiento que sustenta el nivel asignado a cada *capability*. La justificación se basa en las reuniones realizadas con Liz Bravo, la validación del BPMN y la revisión del funcionamiento actual del proceso.

Tabla 7: Justificación de la evaluación de las capabilities del Modelo de Hammer

Capability	Nivel	Justificación
Propósito	P2	El proceso posee un propósito claro: transformar información registrada en RISPACS en reportes y análisis útiles para revisar producción, ventas, ingresos y comportamiento de financiadores. Durante el levantamiento fue posible identificar con claridad la finalidad del proceso y su aporte a la gestión interna de MauleMed.

Capability	Nivel	Justificación
Contexto	P2	El proceso se encuentra correctamente vinculado con otros procesos internos, especialmente Atención Clínica, Gestión Comercial, Gestión Financiera y Gestión Operacional. La información utilizada proviene de registros operacionales y luego es utilizada por jefatura como insumo para el análisis y toma de decisiones.
Documentación	P1	Si bien el proceso pudo ser documentado mediante el presente levantamiento y modelado BPMN, no se identificó un procedimiento formal previamente establecido que describa sus actividades, criterios de clasificación, responsables, formatos de trabajo o reglas de tratamiento de información.
Conocimiento	P1	La responsable principal conoce el proceso y puede ejecutarlo correctamente; sin embargo, dicho conocimiento se encuentra concentrado principalmente en Liz Bravo y depende de su experiencia práctica. No se identificó evidencia de documentación formal, manual de ejecución o transferencia sistemática de conocimiento que permita asegurar que otra persona pueda realizar el proceso con el mismo criterio.
Habilidades	P1	El proceso requiere manejo de RISPACS, uso de Excel y comprensión de criterios de gestión clínica, comercial y administrativa. Si bien estas habilidades están presentes en la responsable actual, su aplicación depende de experiencia individual y trabajo manual, especialmente en la clasificación e interpretación de la información descargada. No se identificaron mecanismos formales de capacitación o estandarización de habilidades para ejecutar el proceso.
Comportamiento	P1	Existe disposición para preparar la información requerida y responder a las necesidades de análisis de la jefatura. Sin embargo, el comportamiento esperado del proceso no se encuentra formalizado mediante rutinas, plazos, controles o mecanismos de seguimiento. La ejecución depende principalmente de la iniciativa y criterio de la responsable, por lo que no alcanza un nivel de madurez plenamente consistente o institucionalizado.
Identidad	P2	Existe una responsable claramente identificada para el proceso. Liz Bravo, Jefe de Administración, concentra la ejecución del flujo y actúa como principal punto de referencia para la generación de información de gestión clínica.
Actividades	P1	Aunque existe una responsable identificada, no se observa una gestión sistemática del desempeño del proceso mediante indicadores, controles formales o revisiones periódicas estructuradas. La gestión se realiza principalmente según la necesidad de información y el conocimiento operativo de la responsable.

Capability	Nivel	Justificación
Sistema de información	P1	RISPACS constituye una fuente centralizada de información para el proceso, lo que representa una base tecnológica relevante. Sin embargo, la reportería no se encuentra completamente automatizada, ya que la información debe descargarse y trabajarse manualmente en Excel para obtener los análisis requeridos.
Recursos Humanos	P1	Los roles principales del proceso se encuentran definidos de manera práctica, especialmente la participación de Liz Bravo y la jefatura. Sin embargo, no se identificaron mecanismos formales de respaldo, capacitación o transferencia de conocimiento que aseguren continuidad operacional frente a la ausencia de la responsable principal.
Definición	P0	No se identificaron indicadores formales para medir el desempeño del proceso, tales como tiempo de elaboración del reporte, frecuencia de generación, cantidad de reprocesos, errores de clasificación o nivel de oportunidad de la información.
Uso	P0	Al no existir indicadores formalmente definidos para evaluar el desempeño del proceso, tampoco se evidencia un uso sistemático de métricas para controlar su ejecución, evaluar desviaciones o impulsar mejoras continuas.

4.9. Diagnóstico de madurez

La evaluación evidencia que el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica cumple su propósito actual, ya que permite transformar información registrada en RISPACS en reportes útiles para revisar producción, ventas, ingresos y financiadores.

Sin embargo, el proceso presenta un nivel de madurez bajo a medio, debido a que depende principalmente del conocimiento operativo de Liz Bravo y del trabajo manual en Excel. No se identifican procedimientos formalizados, reglas documentadas de clasificación ni mecanismos sistemáticos de control del desempeño.

En consecuencia, el proceso funciona correctamente para su complejidad actual, pero presenta oportunidades de mejora asociadas a formalización, estandarización del archivo de trabajo y trazabilidad de la información generada.

4.10. Perfil de Madurez del Proceso

Con el propósito de sintetizar los resultados del Modelo de Hammer, se calculó el nivel promedio alcanzado por cada facilitador evaluado. La Tabla 8 resume el perfil de madurez del proceso.

Tabla 8: Perfil de madurez por facilitador

Facilitador	Nivel Promedio	Madurez	Diagnóstico
Diseño	1.67	P2	Medio
Ejecutores	1.00	P1	Bajo
Responsable	1.50	P1	Medio
Infraestructura	1.00	P1	Bajo
Métricas	0.00	P0	Muy Bajo

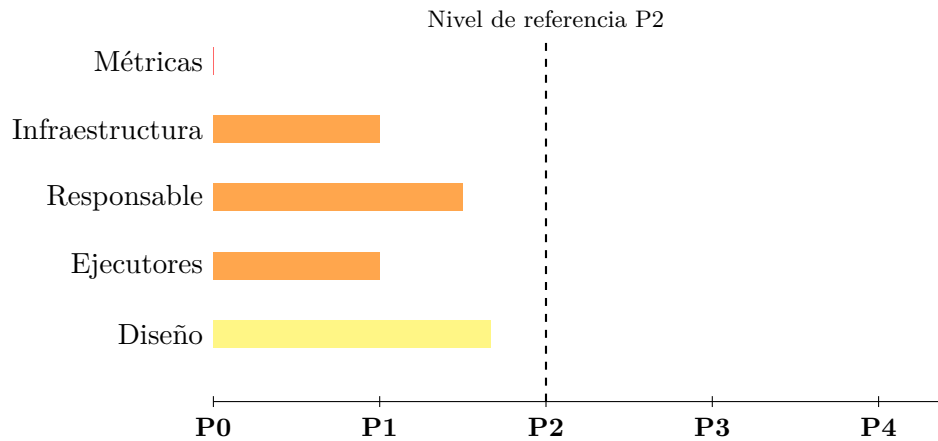


Figura 3: Perfil de madurez del proceso según los facilitadores del Modelo de Hammer.

4.11. Análisis Ejecutivo

El perfil de madurez muestra que el proceso posee un diseño comprensible y un propósito claro, pero su ejecución aún depende de prácticas manuales y del conocimiento individual de la responsable principal.

La principal fortaleza del proceso es que existe claridad sobre su objetivo y sobre la fuente de información utilizada. RISPACS permite obtener los datos necesarios para el análisis, mientras que Excel permite preparar los reportes requeridos por la jefatura.

Las principales brechas se encuentran en la baja formalización del procedimiento, la dependencia del trabajo manual en Excel y la ausencia de indicadores formales del proceso. Por ello, las mejoras deben enfocarse en documentar el flujo, reducir la manipulación manual de datos y fortalecer la trazabilidad de la información mediante una solución conectada a RISPACS.

4.12. Diagnóstico Estratégico y Oportunidades de Mejora

El análisis del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica permitió identificar fortalezas y brechas asociadas a su funcionamiento actual. Si bien se trata de un proceso simple y con pocos participantes, cumple una función relevante al transformar datos de RISPACS en información útil para la gestión interna.

Los principales hallazgos se relacionan con la dependencia del trabajo manual en Excel, la concentración del conocimiento en Liz Bravo, la baja formalización del procedimiento y la trazabilidad limitada de los archivos utilizados.

4.13. Hallazgos Principales

La Tabla 9 resume los principales hallazgos identificados durante el diagnóstico, indicando la evidencia que los respalda y el impacto que generan sobre el desempeño del proceso.

Tabla 9: Principales hallazgos del diagnóstico del proceso de Control e Informes de Gestión Clínica

ID	Hallazgo	Evidencia	Impacto
H1	Alta dependencia del conocimiento de Liz Bravo	La ejecución del proceso se concentra principalmente en Liz Bravo, quien conoce los criterios de descarga, filtrado, clasificación e interpretación de la información proveniente de RISPACS.	Alto
H2	Tratamiento manual de información en Excel	La información se descarga desde RISPACS y posteriormente se trabaja manualmente en Excel, donde se aplican filtros y criterios de clasificación por sucursal, tipo de examen, prestador, financiador, institución, sociedad y valor.	Alto
H3	Baja formalización del procedimiento	No se identificó un procedimiento formal que documente el paso a paso del proceso, los criterios de clasificación, las reglas de tratamiento de datos o la estructura estándar de los reportes.	Medio
H4	Limitada trazabilidad del tratamiento de datos	El proceso depende del trabajo manual sobre archivos Excel, lo que dificulta identificar con claridad qué filtros, ajustes o criterios fueron aplicados en cada ejecución.	Medio
H5	Ausencia de indicadores de desempeño del proceso	No se identificaron métricas formales para monitorear tiempo de elaboración, frecuencia de emisión, errores de clasificación, reprocesos u oportunidad de entrega de la información.	Alto
H6	Información de gestión no disponible de forma inmediata	Aunque la información sería útil para apoyar decisiones de gestión con mayor oportunidad, actualmente su preparación requiere descarga, filtrado y análisis manual, lo que limita la disponibilidad inmediata de reportes.	Medio

4.14. Oportunidades de Mejora

Los hallazgos identificados permiten establecer oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la ejecución del proceso, disminuir la dependencia de actividades manuales y mejorar la disponibilidad de información para la toma de decisiones.

La Tabla 10 presenta la relación entre los principales hallazgos detectados y las oportunidades de mejora propuestas.

Tabla 10: Oportunidades de mejora identificadas para el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica

Hallazgo	Oportunidad de mejora
Dependencia del conocimiento de Liz Bravo	Documentar criterios básicos de análisis, responsables y principales variables utilizadas para la revisión de información de gestión.
Tratamiento manual de información en Excel	Implementar un dashboard conectado vía API a RISPACS que permita consultar y visualizar la información sin depender de la preparación manual de reportes en Excel.
Baja formalización del procedimiento	Definir un flujo estándar para la consulta, revisión y validación de información desde el dashboard.
Limitada trazabilidad del tratamiento de datos	Incorporar en el dashboard registros de actualización, período consultado, origen de los datos y responsable de revisión.
Información no disponible de forma inmediata	Automatizar la actualización de datos desde RISPACS mediante API, permitiendo acceder a información de producción, ventas e ingresos con mayor oportunidad.

En términos generales, las oportunidades de mejora no requieren rediseñar completamente el proceso. Dado su bajo nivel de complejidad, resulta más adecuado avanzar mediante documentación del procedimiento, estandarización de la plantilla Excel y mecanismos simples de respaldo y control de versiones.

4.15. Plan de Transformación del Proceso

El diagnóstico realizado permitió identificar que el proceso cumple su propósito actual, pero presenta brechas asociadas a la dependencia del trabajo manual en Excel, la baja formalización del procedimiento y la limitada trazabilidad del tratamiento de datos.

Dado que el flujo es simple y cuenta con pocos participantes directos, el plan de transformación se orienta a fortalecer gradualmente su estandarización, trazabilidad y soporte operativo, sin sobredimensionar la solución requerida.

El plan propuesto busca generar una base ordenada para mejorar la ejecución actual del proceso y preparar condiciones para futuras iniciativas de automatización o reportería directa desde RISPACS.

4.16. Objetivos de la Transformación

El Plan de Transformación busca evolucionar el proceso de Control e Informes de Gestión Clínica hacia un modelo más estandarizado, trazable y confiable para apoyar la toma de decisiones internas.

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Disminuir la dependencia del conocimiento tácito de la responsable principal.
- Estandarizar la forma de consultar y visualizar la información proveniente de RISPACS.

- Mejorar la trazabilidad de las actualizaciones, períodos consultados y datos utilizados en los reportes.
- Reducir errores o reprocesos asociados al tratamiento manual de información en Excel.
- Facilitar la continuidad operacional mediante una estructura de trabajo replicable.
- Generar una base funcional para la implementación de un dashboard conectado vía API a RIS-PACS.

4.17. Ejes Estratégicos de Transformación

El Plan de Transformación se estructura sobre tres ejes estratégicos, definidos a partir de las principales brechas identificadas durante el diagnóstico.

- **Estandarización del proceso:** documentar el paso a paso del proceso, los criterios de análisis y las principales variables que deben visualizarse en el dashboard.
- **Trazabilidad y control de información:** registrar fecha de actualización, período consultado, origen de los datos y responsable de revisión dentro del dashboard.
- **Disponibilidad de información para la gestión:** reducir el esfuerzo manual necesario para preparar reportes y facilitar el acceso oportuno a información de producción, ventas e ingresos.

Estos ejes permiten abordar las oportunidades de mejora identificadas manteniendo un enfoque práctico, gradual y proporcional a la complejidad del proceso.

4.18. Propuestas de Transformación

El Plan de Transformación se materializa en una propuesta principal orientada a disminuir el trabajo manual asociado a la obtención, preparación y análisis de información proveniente de RIS-PACS.

Dado que el proceso actual depende de la descarga manual de información y su posterior tratamiento en Excel, la mejora más pertinente consiste en implementar un dashboard conectado mediante API a RIS-PACS. Esta solución permitiría consultar y visualizar la información requerida por la jefatura de manera más directa, aplicando filtros de análisis y manteniendo trazabilidad sobre la actualización de los datos.

4.18.1. Propuesta 1. Dashboard de reportería conectado vía API a RISPACS

Aspecto	Descripción
Problema	La información de gestión se obtiene actualmente desde RISPACS y luego debe ser trabajada manualmente para aplicar filtros, clasificar datos y preparar reportes. Esto limita la disponibilidad oportuna de información y aumenta la dependencia del trabajo manual.
Objetivo	Reducir el trabajo manual asociado a la preparación de reportes, permitiendo que la información registrada en RISPACS pueda ser consultada y visualizada de manera más directa mediante un dashboard conectado a la API del sistema.
Propuesta	Desarrollar un dashboard de reportería conectado vía API a RISPACS, que permita obtener automáticamente los datos relevantes del proceso y visualizarlos mediante filtros de gestión. El dashboard debería permitir analizar información de producción, ventas, ingresos, prestaciones, prestadores, financiadores, instituciones y sucursales. Además, la solución debería registrar información básica de trazabilidad, como fecha de actualización, período consultado, origen de los datos y responsable de revisión o validación.
Beneficios esperados	■ Menor dependencia de la descarga y tratamiento manual de información. ■ Mayor disponibilidad y oportunidad de los reportes de gestión. ■ Visualización más clara de producción, ventas e ingresos. ■ Posibilidad de aplicar filtros de análisis de forma directa. ■ Mayor trazabilidad sobre la actualización y uso de los datos. ■ Mejor apoyo a la toma de decisiones de jefatura.
Ejes estratégicos	Disponibilidad de información para la gestión; trazabilidad y control de información.
Prioridad	Alta.

4.18.2. Alineación estratégica de la propuesta

La propuesta de implementar un dashboard de reportería conectado vía API a RISPACS se relaciona directamente con los ejes estratégicos definidos para la transformación del proceso. Su objetivo es reducir el trabajo manual, mejorar la disponibilidad de información y mantener mayor trazabilidad sobre la actualización de los datos.

La Tabla 11 resume la relación entre la propuesta y los ejes estratégicos definidos.

Tabla 11: Alineación entre la propuesta de transformación y los ejes estratégicos

Propuesta	Estandarización del proceso	Trazabilidad y control de información	Disponibilidad de información para la gestión
Dashboard de reportería conectado vía API a RISPACS	✓	✓	✓

Como se observa en la Tabla 11, la propuesta contribuye a los tres ejes estratégicos definidos. Por una parte, estandariza la forma en que se consulta y analiza la información proveniente de RISPACS. Además, permite registrar elementos de trazabilidad como fecha de actualización, período consultado y origen de los datos. Finalmente, facilita que la jefatura acceda a información de gestión de manera más rápida y ordenada.

4.19. Roadmap de Implementación de la Transformación

La implementación de la propuesta de tablero de reportería debe realizarse de forma gradual, considerando que el proceso actual es simple y se apoya principalmente en la descarga de información desde RISPACS y su posterior análisis en Excel.

El roadmap propuesto busca ordenar la transición desde el trabajo manual actual hacia un modelo en que el dashboard se conecte mediante API a RISPACS, permitiendo consultar la información mediante filtros y mantener trazabilidad sobre la actualización de los datos.

4.19.1. Fase 0. Diagnóstico y levantamiento del proceso

Esta fase corresponde al trabajo desarrollado durante la presente consultoría. Su propósito fue comprender el funcionamiento actual del proceso, identificar sus principales actividades y reconocer oportunidades de mejora.

Durante esta etapa se desarrollaron los siguientes entregables:

- Levantamiento del proceso mediante reuniones con Liz Bravo.
- Documentación del flujo actual del proceso.
- Modelamiento BPMN AS IS.
- Aplicación del Modelo de Madurez de Hammer.
- Identificación de hallazgos y oportunidades de mejora.

- Definición de una propuesta de transformación.

Esta fase se considera completada y constituye la base para avanzar hacia la implementación de la mejora propuesta.

4.19.2. Fase I. Diseño funcional del tablero

En esta fase se debe definir el alcance funcional del tablero de reportería. El objetivo es establecer qué información será visualizada, qué filtros serán necesarios y qué datos de trazabilidad deberán quedar registrados en cada carga.

Las principales actividades recomendadas son:

- Definir los datos de RISPACS que deberán ser consultados mediante API.
- Identificar los filtros requeridos para el análisis, tales como fecha, sucursal, tipo de examen, prestador, financiador, institución y valor.
- Definir las vistas principales del dashboard para producción, ventas e ingresos.
- Establecer los datos de trazabilidad que deberán registrarse en cada actualización.
- Validar el diseño funcional con Liz Bravo y jefatura.

4.19.3. Fase II. Desarrollo e implementación piloto

Una vez definido el diseño funcional, se recomienda desarrollar una versión piloto del tablero. Esta versión debe permitir consultar información desde RISPACS mediante API y visualizarla mediante filtros básicos.

Las principales actividades recomendadas son:

- Construir una versión inicial del dashboard.
- Configurar la conexión con la API de RISPACS.
- Crear filtros y visualizaciones principales.
- Incorporar registro de fecha de actualización, período consultado y origen de los datos.
- Probar el dashboard con datos reales provenientes de RISPACS.

4.19.4. Fase III. Validación y ajustes

En esta fase se debe validar si el tablero responde correctamente a las necesidades de análisis de la jefatura y si reduce el trabajo manual realizado actualmente en Excel.

Las principales actividades recomendadas son:

- Revisar la consistencia de los datos visualizados.
- Comparar los resultados del tablero con reportes elaborados manualmente.
- Ajustar filtros, tablas o visualizaciones según retroalimentación de los usuarios.
- Validar la utilidad del tablero para revisar producción, ventas, ingresos y financiadores.

4.19.5. Fase IV. Uso operativo y mejora continua

Finalmente, una vez validado el tablero, este puede incorporarse como herramienta de apoyo al proceso. Su uso permitiría mantener una forma más ordenada y trazable de consultar la información descargada desde RISPACS.

Las principales actividades recomendadas son:

- Definir una rutina de actualización periódica de los datos mediante la API.
- Mantener registro de las actualizaciones realizadas y períodos consultados.

- Revisar periódicamente la utilidad de los filtros y visualizaciones.
- Incorporar nuevas vistas o criterios de análisis según necesidades futuras.

4.20. Impacto Esperado de la Transformación

La implementación del dashboard conectado vía API a RISPACS permitiría mejorar la forma en que MauleMed consulta y analiza información de gestión clínica. El impacto esperado se relaciona principalmente con la reducción del trabajo manual, una mayor oportunidad de la información y una visualización más rápida de los datos relevantes.

Tabla 12: Impacto esperado de la implementación del dashboard conectado vía API a RISPACS

Dimensión	Impacto esperado	Valor para MauleMed
Operacional	▪ Menor trabajo manual en Excel. ▪ Preparación más rápida de reportes. ▪ Aplicación más simple de filtros de análisis.	▪ Mayor eficiencia en la generación de información. ▪ Menor riesgo de errores manuales.
Información	▪ Visualización ordenada de producción, ventas e ingresos. ▪ Consulta de información por sucursal, prestador, financiador e institución.	▪ Mejor apoyo al análisis de gestión. ▪ Información más clara para jefatura.
Trazabilidad	▪ Registro de fecha de actualización. ▪ Identificación del origen de los datos. ▪ Control del período consultado y responsable de revisión.	▪ Mayor control sobre los reportes generados. ▪ Facilidad para revisar información histórica.

En síntesis, la transformación propuesta permitiría mantener la lógica actual del proceso, pero reduciendo la dependencia de descargas manuales y trabajo posterior en Excel. Esto facilitaría que la información registrada en RISPACS sea consultada de manera más rápida, ordenada y trazable mediante un dashboard de gestión.

4.21. Análisis de Riesgos e Impacto Organizacional

La mantención del proceso en su estado actual no representa un riesgo crítico para la operación de MauleMed, pero sí puede afectar la oportunidad, trazabilidad y confiabilidad de la información utilizada para la gestión interna.

Los principales riesgos se relacionan con la dependencia del trabajo manual, la concentración del conocimiento en una persona y la limitada disponibilidad de información actualizada para la jefatura.

Tabla 13: Principales riesgos asociados al proceso actual y propuestas de mitigación

Riesgo identificado	Consecuencia para la organización	Impacto	Propuesta de mitigación
Dependencia de Liz Bravo	La ejecución del proceso depende del conocimiento operativo de la responsable principal, especialmente en la interpretación y clasificación de la información.	Medio	Documentar criterios básicos de análisis y apoyar la ejecución mediante un dashboard conectado a RISPACS.
Trabajo manual en Excel	La preparación manual de reportes puede generar errores, reprocesos o diferencias entre análisis realizados en distintos períodos.	Medio	Automatizar la consulta y visualización de datos mediante conexión API entre RISPACS y el dashboard.
Baja trazabilidad de la información	Puede ser difícil identificar cuándo fue actualizada la información, qué período fue consultado o qué datos fueron utilizados para un análisis.	Medio	Registrar en el dashboard la fecha de actualización, período consultado, origen de los datos y responsable de revisión.
Información no disponible oportunamente	La jefatura puede no contar con información actualizada de forma rápida para revisar producción, ventas, ingresos o financiadores.	Medio	Implementar una actualización periódica de datos mediante la API de RISPACS.

En términos organizacionales, estos riesgos no implican una falla estructural del proceso, pero sí reflejan oportunidades para mejorar la forma en que MauleMed consulta y utiliza su información de gestión. La implementación del dashboard permitiría reducir el trabajo manual, mejorar la trazabilidad de los datos y facilitar el acceso oportuno a información relevante para la toma de decisiones.